

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении "Порядка и периодичности проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров"

С целью обеспечения безопасности труда, охраны здоровья, предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний и несчастных случаев, снижения уровня заболеваний, повышения качества проведения медицинских осмотров и их регулирования на основании статьи 31 Закона Республики Таджикистан "Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения" в соответствии пункта 6 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Таджикистан, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006г. [№603](#),

Р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердить Порядок и периодичность проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. (Прилагается)

2. Начальникам Управления здравоохранения Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Согдийской областей и города Душанбе, главным врачам центральных больниц городов и районов республиканского подчинения:

а) организовать проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров согласно данного порядка в специализированных государственных лечебно-профилактических учреждениях;

б) на основании анализа результатов медицинских осмотров с целью улучшения и охраны здоровья населения, принять соответствующие меры для безопасности труда, предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, а также восстановления трудоспособности работников.

3. Руководителю Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Таджикистан (Алиев С.П.), директорам центров государственного санитарноэпидемиологического надзора Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения:

а) усилить санитарно-эпидемиологический надзор за своевременностью, качеством и полнотой проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, особенно медицинских осмотров проводимых с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний принять соответствующие меры по отношению лиц, предприятий и организаций, сотрудники которых уклоняются от прохождения медицинских осмотров согласно действующему законодательству Республики Таджикистан;

б) усилить надзор за выполнением норм гигиены труда, особенно в предприятиях, где условия труда работников связаны с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами; разработать методические рекомендации по улучшению условий труда, снижению воздействия вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов и контролировать их выполнение.

4. Директору Республиканского клинического центра профессиональных заболеваний (Амиршоев Ш.Т.):

а) согласно нормативных правовых актов Республики Таджикистан и настоящего распоряжения совместно с учреждениями отрасли здравоохранения республики обеспечить организацию проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, трудовая деятельность которых связано с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами;

б) оказать организационно-методическую помощь учреждениям отрасли здравоохранения республики по организации и проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, трудовая деятельность которых связана с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами;

в) в Республиканском клиническом центре профессиональных заболеваний организовать проведение научно-исследовательских работ по внедрению новых методов диагностики и лечения профессиональных заболеваний и восстановления трудоспособности больных.

5. Ректорам Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино (урбонов У.А.) и Таджикского института последипломной подготовки медицинских кадров (Ахмедов А.А.): содействовать в прохождении циклов повышения квалификации и специальной подготовки специалистам лечебно-профилактических учреждений, которые проводят медицинские осмотры

6. Право установления диагноза и выдачи заключение о профессиональном заболевании в соответствии действующего порядка возложить на Республиканский клинический центр профессиональных заболеваний.

7. Настоящее распоряжение представить в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Таджикистан.

8. Настоящее распоряжение ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

9. Признать утратившим силу распоряжение министра здравоохранения Республики Таджикистан от 30.07.2011г. №422 "О проведении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров".

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (Джобирова С.Б.) и заместителей министра здравоохранения (Рахмонов С.Б., Мирзоев А.С.).

Министр

Н. Салимов

от 31 октября 2012г. № 536

г. Душанбе

Утверждена

Распоряжением Министра

Здравоохранения РТ

№536, от 31 октября 2012 года

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящий порядок разработан на основании статьи 31 Закона Республики Таджикистан "Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения" и определяет порядок, периодичность, организацию и проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

Обязательные медицинские осмотры это комплекс лечебно-профилактических мероприятий проводимых в целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний и несчастных случаев, а также с целью определения соответствия, состояния, здоровья работника поручаемой ему работы.

2. Обязательные медицинские осмотры состоит:

а) предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу). Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работы;

б) периодические медицинские осмотры. Периодические медицинские осмотры включают в себя периодичность (кратность) медицинских осмотров работников с учетом выполняемой работы и среды связанной с ее выполнением. Периодичность (кратность) медицинского осмотра зависит от времени необходимого для наблюдения за изменением состояния здоровья работника и от цели осмотра.

Периодические медицинские осмотры проводятся в процессе трудовой деятельности работника с целью:

- определения соответствия состояния здоровья работника выполняемой им работы (должностные обязанности);

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных (отравлений) и инфекционных (паразитарных) заболеваний, ранних признаков воздействий вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работника;

- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и опасных производственных факторов и имеющие медицинские противопоказания для выполнения должностных обязанностей;

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников.

в) Внеочередные медицинские осмотры:

- если работник считает, что ухудшение состояния его здоровья связана с условиями труда он в праве потребовать проведения внеочередного медицинского осмотра.

г) Водители автомобильных транспортных средств подвергаются предрейсовыми, текущими и послерейсовыми медицинскими осмотрами.

3. Медицинские осмотры работников подразделяются на две группы:

а) ____ I группа. Медицинские осмотры проводимые с целью определения соответствия здоровья работника к выполняемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний. Таким осмотрам подлежат работники занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условия труда, в том числе на подземных, ночных работах и работающих на автотранспортных средствах. Перечень работников, деятельность которых связано с вредными производственными факторами определена Правительством Республики Таджикистан. (Постановление Правительства Республики Таджикистан №702 от 31 декабря 2010г.).

б) II группа. Медицинские осмотры, проводимые с целью охраны здоровья предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний. Таким медицинским осмотрами подвергаются работники отраслей пищевой промышленности, общественного питания, торговли, медицины, образований, коммунальных служб и других отраслей непосредственно обслуживающие население.

2. Организация и проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, связанных с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами

4. В соответствии Трудового кодекса Республики Таджикистан работодатель обязан организовать проведения предварительного при заключении трудового договора (контракта) и периодических в процессе работе обязательных медицинских осмотров работников занятых на тяжелых работах с вредными или опасными условиями труда, в том числе на подземных и ночных работах, а также на работах, связанных с движением транспортных средств в целях определения соответствия выполняемой работе состояния их здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний.

5. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу проводятся для определения соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работы, а также с целью предупреждения профессиональных заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда.

6. Периодические медицинские осмотры работников связанных с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами проводятся с целью:

а) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействий вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска;

б) выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы связанной с воздействием вредных и опасных производственных факторов;

в) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников.

7. Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся государственными медицинскими организациями работники которых проходили специализированные курсы по профессиональным болезням и имеющими лицензию на указанный вид деятельности. С целью обеспечения доступности медицинского обслуживания и не отвлечения работников от производства:

- график работы медицинских учреждений, которые проводят обязательные медицинские осмотры приводится в соответствии с графиком работы организации и рабочего время работников;

- при обеспечении соответствующих санитарно-эпидемиологических условий по обоюдному согласованию обязательные периодические медицинские осмотры проводятся на базе предприятия работников со стороны выездной бригады медицинского учреждения.

8. Предварительным (при поступлении на работу, перевод на другую работу) медицинским осмотрам подлежат лица, которые в будущем исполнение их обязанностей будет связано с воздействием вредных и неблагоприятных факторов производств.

9. Администрация учебных заведений и курсов по профессиональной подготовке случаях, если после их окончания лица по роду своей деятельности будут подвергаться воздействию вредных и неблагоприятных условий труда, обязаны направить указанный контингент для проведения предварительных медицинских осмотров до начала обучения.

10. Если по результатам предварительного медицинского осмотра определяются медицинские противопоказания к выполнению работы связанной с воздействием вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами, освидетельствуемые к работе не допускаются.

11. В случае перевода работника на другую работу для которого характерно аналогичное с прежней работе воздействия вредных и неблагоприятных условия труда предварительные медицинские осмотры не проводятся.

12. Для прохождения предварительного медицинского осмотра (при поступлении на работу, перевод на другую работу) администрация предприятий выдает освидетельствуемому в соответствии с приложением 1 настоящего порядка направление для обращения в лечебно-профилактическое учреждение, проводящее медицинские осмотры. В направлении указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия освидетельствуемого вредные факторы и неблагоприятные условия труда.

13. Администрация предприятия обеспечивает лиц, направленных на предварительные медицинские осмотры, бланками направлений.

14. Периодическим медицинским осмотрам подвергается все работники, деятельность которых связана с воздействием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов.

15. Периодичность медицинских осмотров - эта частота (кратность) проведения медицинских осмотров. Периодичность и объем проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров выполнения некоторых работ связанных с вредными веществами и неблагоприятными условиями труда приведена в приложение 2 настоящего порядка.

16. В соответствии статьи 31 Закон Республики Таджикистан "Об обеспечении санитарноэпидемиологической безопасности населения" в случае необходимости, на основании предложений органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, органами местной власти, в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников.

17. В соответствии "Трудового кодекса Республики Таджикистан" работник в праве потребовать проведения внеочередного медицинского осмотра, если он считает, что ухудшение состояния его здоровья связано с условиями труда.

18. Периодические медицинские осмотры работников досрочно проводятся на основании медицинского заключения или обоснованного заключения органов Службы государственного санитарноэпидемиологического надзора.

19. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, администрация предприятий и медицинское учреждение имеют право направить работника досрочно на медицинские осмотры (после перенесенного заболевания, травмы и прочие). В этом случае в направлении указываются причины досрочного направления на медицинский осмотр.

20. Периодические медицинские осмотры вахтовых работников могут быть проведены в территориальном медицинском учреждениях места выполнения работы.

21. Администрация предприятий совместно с представителем Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора с целью планирования проведения медицинских осмотров на следующий год не позднее 1 декабря текущего года составляет список работников подлежащих периодическим медицинским осмотрам. В списке должно полностью указываться фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая должность, стаж работы, адрес работника, связь трудовой деятельности с вредными веществами и неблагоприятными условиями труда. Список согласовывается с Центром государственного санитарноэпидемиологического надзора и предоставляется медицинскому учреждению, которая проводит медицинские осмотры.

22. Администрация предприятий издает распоряжение о проведении медицинских осмотров и обязан в соответствии с распоряжением, обеспечить прохождение медицинских осмотров работников своевременно и в полном объеме.

23. Администрация предприятий имеет право не допускать к работе работников которые уклоняются от прохождения медицинских осмотров или не выполняют рекомендации по их результатам.

24. Администрация медицинского учреждения которая проводит периодические медицинские осмотры на основании представленного списка администрации предприятий составляет календарный план проведения медицинских осмотров. План согласовывается с администрацией предприятия в части время проведения осмотра и с Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в части учета всех работников.

25. Руководитель медицинской организации, осуществляющей предварительные и периодические медицинские осмотры, утверждает состав медицинской комиссии. Председателем комиссии назначаются врач профпатолог или иной специальности имеющий специальную подготовку по профпатологии. В состав комиссии должны включаться специалисты прошедшие в рамках своей специальностей подготовку по профессиональной патологии. Если медицинское учреждение специализированно в направлении проведения медицинских осмотров, тогда приказ об утверждении состава медицинской комиссии не издается.

26. Руководитель медицинского учреждения обязан качественно и в полном объеме организовать проведения медицинских осмотров. С этой целью он обязан обеспечить прохождение работников повышения квалификации и специальных подготовительных курсов, а также проведение всех необходимых лабораторных обследований и обеспечить учреждение необходимыми оборудованием и инвентарем.

27. Основным лицом, проводящем предварительные и периодические медицинские осмотры, является врач терапевт. В предварительных медицинских осмотрах участие всех специалистов

(невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, дерматовенеролога, хирурга и др. или семейного врача) порядку является обязательным.

28. При проведении периодических медицинских осмотров и отсутствие медицинского показания врачом-терапевтом в случае достаточной его подготовке определяется участие других специалистов. Привлечение по медицинским показаниям других врачей специалистов или проведение дополнительных обследований, также определяется врачом-терапевтом.

29. Медицинские специалисты, которые проводят медицинские осмотры должны быть достаточно информированы о связи возникновения и осложнения профессиональных заболеваний с особенностью производства и воздействия вредных факторов.

30. Медицинские специалисты которые участвуют в предварительных и периодических медицинских осмотрах при решении вопроса о годности к работе (отсутствия медицинского противопоказания) руководствуются перечнем медицинских противопоказаний. Перечень заболеваний - медицинских противопоказаний для работников, связанных с воздействием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов и общие медицинские противопоказания определена в приложении 1 настоящего порядка.

31. Вопрос о пригодности работника решается в каждом отдельном случае индивидуально с учетом особенности функционального состояния организма, характера и выраженности патологического процесса, возраста, стажа работы, условия труда работника и др.

32. При необходимости, следует запросить медицинскую документацию с других лечебно-профилактических учреждений.

33. В случаях, когда в медицинские противопоказания включены психические заболевания, алкоголизм, наркомания и токсикомания, в лечебно-профилактические учреждения проводящие медицинские осмотры представляется, справка о пригодности обследуемого к работе из психоневрологического и наркологического диспансера (отделение, кабинетов) по месту постоянной прописки.

34. Работник, для прохождения медицинских осмотров в лечебно-профилактическое учреждение представляет направление выданное работодателем, в котором указано стаж работы, цех, профессия, вредные факторы и неблагоприятные условия труда, а также документ подтверждающий его личность (паспорт и др.) амбулаторную карту или выписку из амбулаторной карты предыдущего места работы, случае требований предусмотренным законодательством справку с психиатрической комиссии (о психическом состоянии).

35. Освидетельствование психиатра (психическом состоянии) осуществляется в специализированном психиатрическом учреждении.

36. Если при проведении медицинских осмотров возникает подозрения или определяются признаки профессиональных заболеваний, медицинская организация для уточнения диагноза и установления связи заболевания с профессиональной деятельностью направляет обследуемого с результатом обследований в центр профпатологии.

37. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора при подозрении или определении признаков профессиональных заболеваний по запросу медицинского учреждения составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда обследуемого или информационную справку. Составленный документ подписывается руководителем Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и направляется с другими медицинскими документами в центр профпатологии для установления окончательного диагноза профессионального заболевания (связи заболевания с профессией). Образец санитарно-гигиенической характеристики условий труда работающего при подозрении у него профессионального заболевания указано в приложении 3 настоящего порядка.

38. Право установления диагноза профессионального заболевания возложено на Республиканский клинический центр профессиональных заболеваний. Установление диагноза профессионального заболевания производится в соответствии нижеследующих документов:

а) список профессионального заболевания (Приложение 1 Постановление Правительства Республики Таджикистан №702 от 30 декабря 2010г.) и инструкция по применению списка профессиональных заболеваний;

б) перечень работ, выполнение которых связано с воздействием вредных веществ и неблагоприятными условиями труда;

в) результаты медицинского осмотра и дополнительных обследований.

39. Установление связи заболевания с трудовой деятельностью (профессией) осуществляет Республиканский клинический центр профессиональных заболеваний. На Республиканский клинический центр профессиональных заболеваний возложено также решение конфликтных случаев возникших при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров.

40. Центр профессиональных заболеваний на основании результатов осмотра и обследований которые представлены медицинским учреждением и при необходимости после проведения дополнительных осмотров (обследований) устанавливает в связи заболеваний с трудовой деятельности (профессии).

41. Центр профессиональных заболеваний при установлении связи заболевания с профессией составляет медицинское заключение и в 3-х дневной срок направляет соответствующее извещение в территориальный орган Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику (случае страхования) и медицинскую организацию, направившего работника. Работник, у которого установлен диагноз профессионального заболевания направляется центром профпатологии с соответствующим заключением в медицинскую организацию по месту жительства. В медицинском учреждении места жительства работника оформляется документы для представления в медико-социальную экспертизу.

42. За период осмотра и обследования обследуемому больничный лист не выдается, а сохраняется заработная плата в соответствии с действующим законодательством.

43. Уточнение или подтверждение диагноза инфекционного (паразитарного) заболевания проводится врачом инфекционистом. Установление связи инфекционного (паразитарного) заболевания с профессиональной деятельностью проводится с участием инфекциониста и эпидемиолога. Карта эпидемиологического обследования является основным документом, подтверждающим профессиональный характер заражения инфекционным (паразитарным) заболеванием. Полнота и правильность заполнения эпидкарты заверяется главным врачом территориального Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

44. Результаты медицинских осмотров заносятся в амбулаторную карту (форма 0,25/у) обследуемого. Результаты предварительных медицинских осмотров заносятся в отдельный лист амбулаторной карты. Каждый специалист участвующие в проведение осмотра выносит заключение о профессиональной пригодности, намечают лечебно-оздоровительные мероприятия. В отдельном листе амбулаторной карты записывается информация о стаже работы, организация, цех, участок, профессия, вредные и опасные производственные факторы. При изменении трудовой деятельности в амбулаторном карте выносятся дополнение. При увольнении или переводе работника на другое предприятие амбулаторная карта с результатами предварительных и периодических медицинских осмотров представляется медучреждению места новой работы.

45. По результатам медицинского осмотра и обследований каждый специалист представляет свое заключения о профессиональной пригодности.

46. Специалисты проводящие медицинские осмотры по результатам медицинских осмотров рекомендуют обследуемому лечебно-оздоровительные мероприятия:

а) динамическое наблюдение и необходимое лечения лиц, у которых выявлены не резко выраженные отклонения со стороны органов и систем в этиологии которых основную роль играет профессиональный фактор;

б) направление на стационарное и санаторно-курортное лечение, дом отдыхов и рекомендация диетпитании (в зависимости от характера выявленных заболеваний);

в) перевод на работу в облегченных условиях при наличии последствий после перенесенного профессионального заболевания, являющегося противопоказанием для продолжения работы в прежних условиях;

г) направление на Врачебную трудовую экспертную комиссию для установления постоянной утраты трудоспособности, установления процента (степенны) трудоспособности.

47. Исполнение рекомендации медицинского заключения о профессиональной пригодности временном или постоянном переводе по состоянию здоровья на другую работу, а также другие рекомендации является обязательным для администрации.

48. Лицам, которым на основании результата предварительного медицинского осмотра признанным пригодным к работе, представляется заключение медицинского осмотра (отрывной талон направления).

49. Лицам, которым по результатам медицинского осмотра признанным непригодным к работе связанное с вредными факторами и в неблагоприятными условиями труда, заключения на руки не выдаются, а пересылаются в трех дневной срок в администрацию предприятия, выдавшего направления.

50. Медицинское учреждение совместно с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), администрацией предприятия и представителя работника (профсоюзный комитет) обобщают результаты периодических медицинских осмотров и составляют акт в четырех экземплярах в соответствии с образцом приведенного в приложении 4 настоящего порядка.

51. К данному акту прилагается поименный список лиц, которым рекомендовано перевод на другую работу, стационарное лечение, диетпитание и др.

52. Заключительный акт представляется для исполнения и контроля в администрацию предприятия, представителю работника (профсоюзный комитет) и Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Один экземпляр остается в медицинском учреждении.

53. Для контроля за состоянием здоровья работников, работающих вахтовым методом, проведения предвахтовых медицинских осмотров является обязательным.

54. Администрация предприятия организует предвахтовые медицинские осмотры в местах выезда на работу или местах выполнения работы.

55. Предвахтовые осмотры включают: сбор анамнеза, измерение температуры тела и артериального давления, определение пульса, проведение реакции на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

56. Результаты предвахтовых медицинских осмотров заносятся в журнал учета осмотров или в личную медицинскую книжку с указанием отметки "допущен к работе".

57. При определении признаков временной или постоянной нетрудоспособности, положительные результаты реакции на наличие алкоголя работник к вахтовой работе не допускается.

58. Работник лично информируется о результатах медицинских осмотров.

59. Медицинские учреждения и территориальные центры профессиональных заболеваний обобщают и анализируют результаты медицинских осмотров проводимые в течение года, предоставляют отчет в Республиканский клинический центр профессиональных заболеваний, территориальному управлению здравоохранения и Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

60. Республиканский клинический центр профессиональных заболеваний, территориальные управления здравоохранения и Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании анализа результатов медицинских осмотров, с целью улучшения и охраны здоровья населения, охраны труда, предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных), массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний, а также восстановление трудоспособности работников, принимают необходимые меры.

3. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров водителей автомобильных транспортных средств

61. Согласно Трудовому кодексу Республики Таджикистан работодатель обязан организовать проведение предварительного, при заключении трудового договора (контракта) и периодических в процессе работы обязательных медицинских осмотров работников, связанных с движением транспортных средств, в целях определения соответствия выполняемой работы, состояния их здоровья.

62. На основании Закона Республики Таджикистан "О дорожном движении" должностные лица отвечающие за эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств, обязаны не допускать к управлению транспортными средствами лиц не прошедших в установленный срок медицинские осмотры, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, в болезненном состоянии или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их реакцию и внимание.

63. Предварительные и периодические медицинские осмотры водителей автотранспортных средств проводятся государственными специализированными медицинскими учреждениями в соответствии с приложением 5 настоящего порядка.

64. При обеспечении необходимых санитарно-эпидемиологических условиях по согласованию сторон, периодические медицинские осмотры могут быть проведены на базе предприятия работников выездной бригадой медицинского учреждения.

65. Предварительному медицинскому осмотру подвергаются лица, деятельность которых в будущем связана с управлением автотранспортных средств, в том числе кандидаты в водители индивидуальных транспортных средств.

66. Администрация профессионально-технических училищ и школы по подготовке водителей до начала обучения обязаны подвергать предварительным медицинским осмотрам абитуриентов и слушателей.

67. Для прохождения предварительного медицинского осмотра, администрация предприятий, Госавтоинспекция, администрация профессионально-технических училищ и школы по подготовке водителей выдает освидетельствуемому в соответствии с приложением 6 настоящего порядка направление в лечебно-профилактическое учреждение, проводящее предварительные осмотры. В направлении указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, и категория автомобильного транспортного средства.

68. Периодичность медицинских осмотров водителей автотранспортных средств - эта частота (кратность) проведения медицинских осмотров с учетом категории автотранспорта.

69. Администрация предприятия, Госавтоинспекция и администрация медицинского учреждения имеют право направлять водителей автотранспортных средств на досрочное медицинское переосвидетельствование в порядке экспертизы (после перенесенного заболевания, травмы и др.), в этом случае в направлении указывается причина направления на досрочный медицинский осмотр.

70. Водитель в праве потребовать проведения не очередного медицинского осмотра, если он считает, что ухудшение состояния его здоровья связано с условиями труда.

71. Периодические медицинские осмотры водителей автотранспортных средств деятельность которых связана с воздействием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов досрочно проводится на основании медицинского заключения или обоснованного заключения органов Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

72. Предварительному медицинскому осмотру подвергаются водители индивидуальных транспортных средств и предприятия независимо от форм собственности и административного подчинения.

73. Администрация предприятия автотранспортных средств, с целью планирования проведения медицинских осмотров на следующий год составляет список водителей, подлежащих периодическим медицинским осмотрам не позднее 1 декабря текущего года и представляет в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В списке должно полностью указываться фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая должность, стаж работы, адрес, категория транспортного средства и неблагоприятные условия труда. Список согласовывается с Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и представляется в медицинские учреждения с которым заключен договор о проведения медицинских осмотров.

74. Администрация предприятий автотранспортных средств издает распоряжение о проведении периодических медицинских осмотров работников, обязан согласно данного распоряжения обеспечить своевременно и в полном объеме их прохождению.

75. Администрация автотранспортного предприятия ответственна за допуск к работе работников которые своевременно не проходят медицинские осмотры или не выполняют рекомендации по их результатам и имеет право эту категорию водителей не допускать к выполнению должностных обязанностей.

76. Своевременное прохождение медицинского осмотра водителей автотранспортных средств также контролируется Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и работниками Госавтоинспекцией (период проведения годового технического осмотра и выборочно).

77. Руководитель медицинского учреждения обязан обеспечить полноту и качественное проведение медицинских осмотров водителей (кандидаты в водители).

78. Наркологическое освидетельствование проводится в наркологическом центре (отделение, кабинеты). Водитель представляет в медицинское учреждение, которое проводит медицинские осмотры справку с центра наркологии (отделение, кабинеты) о состоянии здоровья.

79. Если в процессе проведения медицинских осмотров возникает необходимость дополнительных осмотров и исследований в других специализированных центрах, тогда водитель направляется в эти центры.

80. Медицинские специалисты участвующие в проведении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (кандидаты в водители), при решении вопроса о пригодности к работе (отсутствии противопоказаний) руководствуются медицинскими противопоказаниями приведенные в приложений 3 настоящего порядка.

81. Вопрос пригодности к водителю решается в каждом случае индивидуально с учетом особенностей функционального состояния организма, характера и выраженности патологического процесса, возраста, стажа работы, условий труда и прочее.

82. Если при проведении медицинских осмотров выявляется заболевания, которое не является медицинским противопоказанием к обязанности водителя, тогда освидетельствуемый допускается к работе и направляется в медицинское учреждение по месту жительства для дообследования и лечения. В направлении указывается выявленное заболевание, дата, результат обследования и название медицинского учреждения, которое выявило заболевание.

83. Если при проведении медицинского осмотра возникают подозрения или выявляются признаки профессиональных заболеваний, медицинское учреждение с целью уточнения и установления связи заболевания с профессиональной деятельностью направляет водителя с обоснованными заключениями в Республиканский клинический центр профессиональных заболеваний.

84. При подтверждении связи заболевания с профессиональной деятельностью центр профессиональных болезней действует в установленном порядке.

85. Для прохождения предварительного медицинского осмотра водители или кандидаты в водители представляют направление в лечебно-профилактическое учреждение, выданное администрацией предприятия, органами Госавтоинспекции, администрацией профессионально-технического училища и школы по подготовке водителей, а также документ подтверждающий личность.

86. Водители индивидуальных транспортных средств для прохождения периодических медицинских осмотров в медицинское учреждение представляют водительское удостоверение и предыдущее заключение медицинской комиссии (медицинскую справку).

87. Результаты периодических медицинских осмотров водителей автотранспортных средств заносятся в амбулаторную карту обследуемого (форма 0,25/у) и медицинскую справку для водителей (форма 083/б).

88. Специалисты, участвующие в проведение медицинских осмотров заносят свои заключения в амбулаторную карту и медицинскую справку, заверяя их печатями и штампами.

89. Медицинская справка с заключениями специалистов заверяется терапевтом, руководителем медицинского учреждения и предоставляется водителю.

90. Медицинское учреждение совместно с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, представителями работодателя и работников (профсоюзный комитет) обобщая результаты периодических медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, составляют акт в четырех экземплярах (согласно пунктами 50- 52).

91. Лицам, у которых по результатам медицинского осмотра выявлено медицинское противопоказание к управлению автотранспортных средств, медицинское заключение не выдается. Медицинское заключение данных водителей пересылаются в трех дневной срок в администрацию предприятия или в Госавтоинспекцию, выдавшего направление.

92. Водители автотранспортных средств, которые непосредственно связаны с транспортировкой пищевых продуктов, кроме осмотров и обследований которые проходят водители в зависимости от пищевой отрасли подвергаются дополнительным осмотрам и обследованиям. В этом случае результаты медицинских осмотров заносятся в амбулаторную карту и личную медицинскую книжку, заверяются штампами и печатью. При выявлении заболевания (патология) которая является медицинским противопоказанием к выполнению обязанности, допуск к работе выдается после лечения и отрицательных результатов исследований.

93. Администрация предприятий, обязана принять соответствующие меры по исполнению рекомендаций выданных на основании результатов медицинских осмотров медицинским учреждением и Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

94. Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств проводятся медицинским работникам предприятий (врачами, фельдшерами, медсестрами, которые имеют профессиональную подготовку в этом направлении), а также специалистами медицинского учреждения, которая обслуживает предприятие на договорной основе.

95. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся с целью выявления водителей которые по состоянию здоровья не допускается к управлению транспортных средств (как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья водителей и пассажиров).

96. Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств является выявление факторов которые снижают их реакцию и внимание (заболевания, употребления алкоголя, наркотических, запрещенных веществ и их остаточные явления, усталости).

97. Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся в организациях (независимо от форм собственности и подчиненности), имеющих автомобильный транспорт.

98. Предрейсовые медицинские осмотры проводится как на базе предприятие, так и на базе медицинского учреждения.

99. Руководители предприятия и медицинского учреждения, которые проводят предрейсовые медицинские осмотры, ответственны за качеством и полноту проведения медицинских осмотров и обязаны:

а) организовать проведение осмотров необходимыми специалистами, и лабораторных (функциональных) исследований;

б) обеспечить методические руководство и контроль за деятельностью медицинских работников, осуществляющих предрейсовые медицинские осмотры;

в) утвердить по согласованию с руководителем предприятий режим работы медицинских работников;

г) обеспечить прохождение специалистами курсов повышения квалификации и специальной подготовки;

д) обеспечить специалистов необходимым оборудованием и бланками учетно-отчетной документации.

100. Для проведения предрейсового медицинского осмотра необходимо помещение, состоящее не менее чем из 2-х комнат (комната для проведения осмотров и комната для отбора биологических средств).

101. Помещение должно быть минимально оснащено следующим оборудованием и инвентарём:

- а) кушетка медицинская;
- б) письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, напольный коврик, сейф;
- в) прибор для определения артериального давления - 2 штуки, термометр - 3 штуки, стетофонендоскоп - 2 штуки;
- г) прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе - 2 штуки;
- д) алкометр, экспресс - тесты на алкоголь и наркотики. Постоянный запас в количестве: алкометр - 2 штук, экспресс - тесты на наркотики - 10 штук;
- е) столик для медицинского оборудования - 1 штука;
- ё) шпатели медицинские - 10 штук;
- ж) сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи - 1 штук.

Комната для отбора биологических средств должна быть оснащена необходимым оборудованием.

102. Водители являются на предрейсовый медицинский осмотр с путевым листом.

103. При предрейсовом медицинском осмотре проводится:

- а) сбор анамнеза состояния здоровья обследуемого;
- б) определение артериального давления и пульса;
- в) определение температуры тела;
- г) определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах одним из официально признанных методов;
- д) при наличии показаний - любые другие разрешенные медицинские исследования, необходимые для решения вопроса о допуске к работе.

104. Медицинский работник, который проводит предрейсовые медицинские осмотры водителя автотранспортных средств, обязан обратить внимание на нижеследующие обстоятельства:

- а) как обследуемый заходит в комнату, походка, внешний вид и поведение;
- б) субъективное состояние, настроение, продолжительность сна, наличие и отсутствие жалоб, на состояние здоровья;
- в) состояние кожного покрова, наличие повреждений, расчесов, следов от инъекции, (особенно в кубитальных ямках), бледность или покраснение кожи;
- г) состояние слизистых оболочек глаз (покраснение, желтушность);
- д) состояние зрачков (суженный, расширенный), как реагирует на свет (хорошо, слабо или отсутствует);
- е) температуры тела;
- ё) показателей пульса и артериального давления.

105. Для водителей больных гипертонической болезнью, определяется индивидуальная норма артериального давления по результатам замеров при не менее чем 10 предрейсовых осмотрах.

106. При выдаче допуска к рейсу в путевом листе ставится штамп: "Предрейсовый медицинский осмотр прошел" и подпись медицинского работника который проводил медицинский осмотр.

107. Водители в нижеследующих случаях не допускаются к управлению автотранспортных средств:

а) при выявлении признаков временной нетрудоспособности (симптомы острого заболевания или обострения хронического заболевания, повышение температуры тела свыше 37,0, головные и зубные боли и др.);

б) при положительном результате теста на наличие алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе или биологических сред;

в) при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ отрицательно влияющих на работоспособность водителя;

г) при выявлении признаков нахождения под действием алкоголя наркотических и психотропных препаратов;

д) при недостаточном отдыхе перед сменой.

108. Водители которые по состоянию здоровья отстранены от работы в дневное время направляются к дежурному врачу лечебно-профилактического учреждения. В том случае если отстранение водителя от работы связана с временной утратой трудоспособности и произошло в вечернее или ночное время (медицинское учреждение не работает) медицинский работник оказал первую помощь, предлагает водителю явиться на следующий день в поликлинику. При этом водителю выдается справка, в котором указывается время освобождения от работы, краткие данные о характере заболевания или травме, о температуре тела и др. Справка составляется в произвольной форме и подписывается медицинским работником.

109. Врач медицинского учреждения утверждая времени не трудоспособность отстраненного от работы водителя выдает ему больничный лист. Если же работник будет признан трудоспособным, ему выдается справка об отсутствии медицинского противопоказания для допуска к работе, на основании которой он допускается к управлению автотранспортным средством. Допуск к работе страдающих гипертонической болезнью или гипотонией, осуществляется строго индивидуально по рекомендациям лечащего врача. Эти рекомендации заносятся в карту состояния здоровья водителя.

110. Если при проведении осмотров выявляются признаки употребления или действия спиртных напитков, наркотических и сильнодействующих лекарственных веществ, водитель подвергается дополнительным исследованиям (проведение контроля трезвости, направления на наркологическое обследование).

111. Медицинский специалист проводит контроль трезвости, по ее результатам составляет акт соответствии с образцом приложения 7 настоящего порядка. При проведении контроля трезвости для определения состояния здоровья осматриваемый водитель в обязательном порядке должен быть подвергнут клиническому обследованию и должна быть проведена лабораторная диагностика биологических сред водителя (выдыхаемый воздух и моча).

112. При положительном результате контроля трезвости (употреблении алкоголя или наркотических веществ) водитель для определения факта употребления алкоголя или наркотических веществ направляется в специализированные центры в соответствии с направлением образца приложения 8 настоящего порядка. В направлении указывается фамилия, имя, место работы, должность, причина направления, дата и время выдачи направления, должность лица который выдал направление и к нему прилагается протокол контроля трезвости.

113. В специализированном медицинском учреждении проводится обследование на выявления употребления алкоголя (наркотических веществ) и составляется протокол в соответствии с образцом приложения 9 настоящего порядка.

114. Лица, с положительными результатов теста по определению употребления алкоголя (наркотических веществ) должно быть доставлено к месту его проведения как можно быстрее но не позднее 2-х часов с момента выявления состояния опьянения. При наличии резко выраженных признаков опьянения, (употребления наркотических веществ), а также отказа обследуемого от освидетельствования, аппаратного либо тестового исследования работодателем составляется акт о появлении работника на рабочем месте в опьяненном состоянии (употребление наркотических веществ).

115. При решении вопроса допуска водителя к управлению транспортных средств, медицинский специалист учитывает принадлежность водителя к одной из групп риска, возраст, стаж и должность, условия работы, характер производственных факторов.

116. Группа риска определяется медицинским специалистом на основании анализа причин не допуска водителей к работе по состоянию здоровья. В эту группу включаются водители, склонные к злоупотреблению алкоголя и психоактивными веществами, а также длительно и часто болеющие (страдающие хроническими заболеваниями) и водители старше 55 лет.

117. Водители вошедшие в группу риска должны подвергаться текущим и послерейсовым медицинским осмотрам и находиться под особым вниманием медицинских работников. Порядок проведения текущих и послерейсовых медицинских осмотров определяет руководитель предприятий.

118. По результатам предрейсовых медицинских осмотров ведется индивидуальный отчет не допуска водителей к работе с применением амбулаторной карты (форма №025/у). В картах указываются результаты осмотров и обследования (история заболевания, объективные показатели осмотров, причина не допуска к работе).

119. Медицинский работник в установленном порядке представляет отчет о результатах предрейсовых медицинских осмотров руководителю предприятия и соответствующим органам.

120. Администрация предприятия, анализируя результаты предрейсовых медицинских осмотров, на основании рекомендации выданными медицинскими специалистами осуществляет оздоровительные мероприятия.

4. Организация и проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников непосредственно обслуживающих население

121. Согласно Трудового кодекса Республики Таджикистан работники, занятые в пищевой промышленности, общественном питании, торговли, и других отраслях, непосредственно обслуживающих население, проходят медицинские осмотры с целью охраны здоровья населения, предупреждения, возникновения заболеваний.

122. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников непосредственно обслуживающих население проводится специализированными государственными медицинскими организациями (отделение, кабинеты) согласно приложением 10 настоящего порядка.

123. С целью не отвращения работников от производства и приближения медицинского обслуживания, при обеспечении необходимых санитарно-эпидемиологических условий, по согласованию сторон, периодические медицинские осмотры могут проводиться, на базе предприятия работников, выездной бригадой медицинского учреждения.

124. Предварительным медицинским осмотрам (при поступлении на работу, перевод на другую работу) подвергается все лица, которые в будущем исполнения их обязанности непосредственно связано с обслуживанием населения.

125. Администрация высших учебных заведений, профессионально-технических училищ и курсов по профессиональной подготовке обязаны перед и в процессе прохождения практики, организовать проведения медицинских осмотров студентов как работники предприятия, на базе которых проводится практика.

126. В случае перевода работника, который проходил медицинский осмотр, на другую работу, особенности исполнения которой согласно принятой порядке требует дополнительного осмотра (обследования), тогда работник должен пройти дополнительные осмотры (обследования) или медицинский осмотр в полном объеме.

127. Администрация предприятия для прохождения предварительного медицинского осмотра (при поступлении на работу, перевод на другую работу) выдает работнику направление для обращения в медицинское учреждение, которое проводит медицинский осмотр в соответствии с образцом приведенного в приложении 11 настоящего порядка. В направлении указывается фамилия, имя, возраст, особенности обязанности работника принимаемого на работу (переводимого на другую работу).

128. Частные лица для прохождения предварительного медицинского осмотра представляют заявление руководителю медицинского учреждения, которое проводит медицинский осмотр в соответствии с образцом приложения 12 настоящего порядка. В заявлении в обязательном порядке указывается особенности исполнения обязанности (обслуживания).

129. Обследуемый в медицинское учреждение наряду с направлением (заявления), предъявляет паспорт или другой документ удостоверяющий личность.

130. Периодичность медицинских осмотров включает в себя частоту (кратность) медицинских осмотров проведения медицинского осмотра работника с учетом условий связанных с исполнением ее обязанности.

131. На основании статьи 31 Закон Республики Таджикистан "Об обеспечении санитарноэпидемиологической безопасности населения", в случае необходимости, на основании предложений органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, органами местной власти, в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников (кратность, обследований, осмотров).

132. Периодические медицинские осмотры работников (частные лица) досрочно проводиться в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой региона, предприятий и цехов на основании обоснованного заключения органов Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

133. Администрация предприятий с целью планирования проведения медицинских осмотров на следующий год не позднее 1 декабря текущего года составляет список работников и представляет в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В списке должно полностью указываться фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая должность и ее особенность, адрес работника. Список согласовывается с Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и представляется в медицинское учреждение, которое проводит медицинские осмотры.

134. Руководитель предприятий обязан, согласно принятого порядка организовать своевременное проведение медицинских осмотров работников.

135. Руководитель предприятия издает распоряжение проведении периодических медицинских осмотров, обязан согласно распоряжению, обеспечить своевременное прохождение работниками медицинских осмотров.

136. При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении им рекомендаций по их результатам работодатель вправе не допускать работника к выполнению трудовых обязанностей.

137. Администрация предприятий обязана, для исполнения рекомендации выданной медицинским учреждением и Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора по результатам медицинских осмотров, с целью оздоровления работников, принять необходимые меры.

138. Медицинское учреждение, проводящее периодические медицинские осмотры на основании полученного от администрации предприятия списка работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, составляет план и график проведения медицинских осмотров. План согласовывается с администрацией предприятия в части сроков, с Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в части полного учета.

139. Руководитель медицинского учреждения обязан организовать проведения медицинских осмотров качественно и в полном объеме. С этой целью он обязан обеспечить прохождение медицинскими специалистами курсов специальной подготовки и повышения квалификаций, а также организовать проведение всех необходимых лабораторных и функциональных обследований и обеспечить учреждение необходимым оборудованием.

140. Врач терапевт или уполномоченный врач являются основным специалистом, который урегулирует проведения медицинских осмотров согласно требованию.

141. При обращении обследуемого в медицинское учреждение врач терапевт (уполномоченный врач) на основании представленного списка или заявления согласно настоящего порядка определяет перечень осмотров и обследований.

142. Лицам, которые в первый раз проходят медицинский осмотр на основании списка представленном предприятием (заявление частного предпринимателя) и документа удостоверяющего личности заполняется личная медицинская книжка и амбулаторная карта.

143. Обследуемый обязан проходить полностью перечень осмотров и обследований, которые были определены врачом терапевтом или уполномоченным врачом.

144. При необходимости по результатам медицинских осмотров на основании обоснованного заключения специалиста проводящего медицинские осмотры проводятся дополнительные осмотры и обследования.

145. Осмотр психиатра (психическое состояние), осмотр нарколога проводится в специализированных психиатрических и наркологических центрах.

146. Медицинское учреждение, которое проводит обязательные медицинские осмотры в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в случае выявления инфекционных (паразитарных) заболеваний в экстренном порядке представляет информацию и каждый месяц отчет о проведении медицинских осмотров в соответствии с образцом приложения 13 настоящего порядка.

147. Результаты медицинских осмотров и обследований заносятся в амбулаторную карту, личную медицинскую книжку, журнал приема специалистов и лабораторий и заверяется личными печатями специалистов и штампами медицинского учреждения. (Образец штампов приведен в приложении 14 настоящего порядка)

148. В регионах, где функционирует специализированная медицинская учреждения по проведению обязательных медицинских осмотров, выдача обследуемым личных медицинских книжек осуществляется этим учреждением.

149. В регионах, где не функционирует специализированная медицинская учреждения по проведению медицинских осмотров, выдача обследуемым личных медицинских книжек осуществляется Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

150. Личная медицинская книжка, которая выдается обследуемому регистрируется в специальном журнале (приложение 15 настоящего порядка) с указанием фамилия, имя, возраст, адрес, названия предприятия и должность, дата заполнения книжки и порядковый номер.

151. В регионах, где функционирует специализированная медицинская учреждения по проведению обязательных медицинских осмотров, на основании результатов медицинского осмотра (при отсутствии медицинского противопоказания) обследуемому врач терапевт дает допуск к работе. В личную медицинскую книжку ставится штамп "Допущен к работе".

152. Если в процессе проведения медицинских осмотров выявляются общее заболевания, которая не является медицинским противопоказанием к выполнению работы, тогда обследуемый допускается к работе с рекомендацией дальнейшего обследования и лечения.

153. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в регионах, где не функционирует специализированные медицинские учреждения по проведению медицинских осмотров, по результатам медицинских осмотров представленным одним из медицинским учреждением региона (при отсутствии медицинского противопоказания), допускает обследуемого к работе. В личную медицинскую книжку ставится штамп "Допущен к работе".

154. В случае выявления инфекционных (паразитарных) заболеваний или их возбудителей в экстренном порядке представляется информация в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При необходимости для подтверждения диагноза проводятся дополнительные осмотры и обследования или обследуемого направляют в другие специализированные учреждения для уточнения диагноза.

155. Лицам, у которых выявлено инфекционное (паразитарное) заболевания или их возбудителей которые является медицинским противопоказанием к выполнению работы (обслуживания), после лечения и повторного обследования допуск к работе выдается только на основании справки выданной Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Перечень медицинских противопоказаний для работников связанных с непосредственным обслуживанием населения, приведено в приложении 16 настоящего порядка.

156. О результатах медицинских осмотров, обследуемый информируется лично.

157. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляет надзор за своевременностью, качеством и полноту проведения медицинских осмотров, принимает согласно

действующему Законодательству Республики Таджикистан необходимые меры в отношении лиц и работников предприятий и организаций которые своевременно не проходит медицинский осмотр или уклоняется от прохождения медицинских осмотров.

158. Территориальные управления здравоохранения и Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора на основании анализа результатов медицинских осмотров, с целью улучшения и охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных), массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), принимают необходимые меры.

5. Оплата медицинского осмотра

159. Согласно статьи 146 Трудового кодекса Республики Таджикистан работники не несут расходов в связи с прохождением медицинского осмотра то есть работодатель оплачивает расходы медицинского осмотра.

160. На основании статьи 18 Закона Республики Таджикистан "О защите труда" работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников (оплата расходов медицинского осмотра).

161. Индивидуальные лица проходят медицинский осмотр за свой счет.

[*Приложение 1-2](#)

Приложение 3

к Порядку и периодичность проведения

обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров

ОБРАЗЕЦ составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда работающего при подозрении у него профессионального заболевания

I. Общее положение

1. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работающего является одним из документов, на основании которого решается вопрос о связи заболевания с профессиональным трудом.

2. Санитарно-гигиеническая характеристика выдается только Службой государственного санитарноэпидемиологического надзора (СГСЭН).

3. Право на запрос санитарно-гигиенической характеристики имеют:

- руководитель медсанчасти предприятия, на котором работает заболевший;
- руководитель территориального лечебно-профилактического учреждения общего профиля, руководитель медицинского учреждения, которое проводит медицинский осмотр;
- руководитель Центра (стационара) профессиональных болезней.

4. Запрос на санитарно-гигиеническую характеристику направляется руководителю СГСЭН по месту расположения предприятия (предприятий), на котором работает (работал) заболевший.

5. Санитарно-гигиеническая характеристика оформляется в 3-х экземплярах на бланках СГСЭН, утверждается подписью руководителем СГСЭН и заверяется печатью. Первый экземпляр санитарногигиенической характеристики выдается запросившему учреждению в течении 15 дней со дня получения запроса второй экземпляр хранится в СГСЭН, третий экземпляр характеристики передается в отдел кадров предприятия. Работник, на которого составлено характеристика, по его просьбе может быть с ней ознакомлен. В случае необходимости переадресования запроса с СГСЭН места настоящей работы в СГСЭН места прежней работы заболевшего срок составления характеристики продлевается по согласованию с руководителем СГСЭН.

6. При необходимости (недостаточность данных, контакт с аналогичными вредными факторами на предыдущей работе и т.п.) запрос на дополнительные данные для санитарно-гигиенической характеристики условий труда следует направить в СГСЭН, выдавшую ее, или в СГСЭН, районированную по предыдущему месту работы.

7. В санитарно-гигиенической характеристике должно указываться наличие или отсутствие случаев профессиональных заболеваний в той профессиональной группе, к которой относится работник.

8. В случае возникновения заболеваний после прекращения контакта с вредными факторами производственной среды (поздний силикоз, некоторые опухолевые заболевания и др.) и невозможности представления данных об условиях труда (ликвидация цеха, участка, предприятия, его реконструкция при отсутствии документов о количественной характеристике вредных факторов) представляют другие документы (выписка из трудовой книжки и др.), подтверждающие связь профессии работника с вредными условиями труда.

9. В случае ликвидации цеха, участка, предприятия возможно моделирование условий труда заболевшего, ссылки на данные литературы по количественной характеристике факторов производственной среды и трудового процесса для аналогичных производств и другие сведения, которые включают в "Информационную справку", составляемое вместо санитарно-гигиенической характеристики.

II. Требования к содержанию санитарно-гигиенической характеристики.

10. В санитарно-гигиенической характеристике последовательно вносятся следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество работника;
- год рождения;
- профессия, должность;
- предприятие, учреждение, ведомственная принадлежность;
- цех (участок, мастерская);
- стаж работы: общий, в данной профессии, в данном цехе (участке, отделе, мастерской);
- характеристика факторов трудового процесса;
- количественная характеристика ведущего фактора;
- количественная характеристика сопутствующих вредных факторов производственной среды;
- описание трудовой деятельности;
- перечень вредных факторов производственной среды имел контакт ранее: перечень факторов, на каком предприятии, длительность контакта со слов работающего, другие материалы);
- хронометражные данные (время действия фактора в течение смены);
- средства индивидуальной защиты и их использование.

11. Описание трудовой деятельности работающего дается на основании ознакомления врача по гигиене труда с должностными обязанностями и характером труда рабочего непосредственно на рабочем месте, и учитывают сведения, полученные от администрации и самого рабочего.

12. Перечень вредных производственных факторов и их количественная характеристика производится на основе материалов СГСЭН (районной, городской, областной, республиканской) по текущему санитарному надзору, результатов лабораторно-инструментальных исследований, научно-исследовательских гигиенических или медицинских институтов. При необходимости используют результаты лабораторно-инструментальных исследований санитарно-гигиенических лабораторий предприятий, ведомств и других специализированных организаций. Результаты исследований должны даваться со ссылкой на учреждение, проводившее замеры уровня вредного фактора, с указанием сроков исследований. Дополнительно могут быть привлечены и другие материалы, в том числе акты расследования случаев профессиональных заболеваний работающих на обследуемом участке, сведения,

сообщение заболевшим, которые подтверждаются представителями администрации или работающими на данном участке.

13. Количественная характеристика вредного фактора производственной среды должна быть представлена в динамике за максимально возможный период работы в данной профессии.

Ведущим фактором производственной среды и трудового процесса является тот, который представляет наибольшую опасность для здоровья работающего. Его характеристика дается в полном объеме (в соответствии с разделом 3) сопутствующие факторы перечисляются и, по возможности, количественно оцениваются.

14. При отсутствии или недостаточности результатов лабораторно-инструментальных исследований, СГСЭН проводит дополнительные замеры на рабочем месте заболевшего.

15. Хронометражные данные представляются в виде времени действия вредного фактора на работающего в течение смены. При неравенстве выполняемой работы в разные смены выбирают другой временной отрезок - месяц, год.

16. Перечисляются используемые средства индивидуальной защиты. В соответствующих случаях делается указание на нарушение использования средств индивидуальной защиты (несоответствие средств индивидуальной защиты действующему фактору, нарушение правил использования и др.)

17. Дается заключение об условиях труда работающего в соответствии с действующим санитарным законодательством (с учетом положений "Гигиенической классификации труда") и о возможности влияния производственной среды на возникновении данного профессионального заболевания (отравления).

III. Требования к характеристике отдельных вредных факторов производственной среды и трудового процесса

18. Шум, локальная, общая вибрация, ультра-инфразвук.

а) Источники.

б) Качественная характеристика фактора:

- шум - постоянный, импульсный;
- локальная вибрация: прерывистая, импульсная (ударная), высоко-, низкочастотная;
- общая вибрация (вибрация рабочих мест): транспортная, транспортно-технологическая;
- ультразвук - воздушный, контактный, постоянный, импульсный;
- инфразвук,

в) Количественные характеристики:

Годы

Эквивалентный уровень за смену

Экспозиция за рабочий стаж

* Примечание:

- для шума - эквивалентный уровень звука в ДБА: дополнительной характеристикой для непостоянного шума является максимальный уровень звука в ДБА;

- для вибрации (локальной и общей) - скорректированные значения виброскорости или виброускорения или их логарифмический уровень в дБ;

- для инфразвука - эквивалентный уровень звукового давления или степень превышения нормы в дБ с указанием частоты октавы наибольшего превышения;

- для ультразвука - рабочая частота установки и превышение нормы в дБ.

г) Наличие факторов, усугубляющих развитие патологического процесса:

- для шума - напряженность труда;
- для локальной вибрации - охлаждение, смачивание рук (с указанием температуры воды, раствора, времени охлаждения);
- для общей вибрации - нагревающий микроклимат с повышенной влажностью.

19. Пыль

а) Характеристика пыли:

- характер и состав пыли: природная или искусственная, минеральная или органическая, однородная или смешанная и т.п.; присутствие газов и паров химических веществ;
- дисперсный состав: аэрозоль конденсации или дезинтергации;
- минералогической, химический состав пыли и другие характеристики физико-химических свойств пыли.

20. Количественные показатели запыленности воздуха рабочей зоны:

Годы

Концентрация, мг/м³

(МРК)

максимально-разовая концентрация

(ССК)

среднесменная концентрация

21. Химические вещества, биологические факторы.

а) Качественная характеристика загрязнений воздуха рабочей зоны, перечень выделяющихся вредных веществ на местах постоянного и временного пребывания работающего с учетом применяемого сырья, промежуточных и конечных продуктов реакции и возможности их превращения (окисление, диструкции, гидролиз и др.).

б) Количественные характеристики выделяющихся вредных веществ:

Наименование вещества ПДК мг/м³ годы Кол-во проб Концентрации, мг/м³ % проб, превышающих ПДК

МР СС

МР СС МР СС

Среднесменную концентрацию измеряют для веществ, имеющих среднесменную ПДК (ПДК сс).

22. Для веществ, опасных при поступлении через кожу (в соответствии с перечнем "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", дать оценку возможности поступления вредных веществ через кожу. Например, непосредственный контакт рук с загрязненным оборудованием, технологическими приспособлениями и т.п., возможность пролива продукта и др.

23. Количественная характеристика степени загрязнения кожных покровов проводится для веществ, имеющих предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук (или ориентировочные предельно-допустимый уровень загрязнения кожи и др.).

24. При подозрении на профессиональное заболевание кожи - указывается полный перечень компонентов (раствора, клея, смолы, сплава и др.), с которыми имеет контакт работающий.

25. Неионизирующие излучения.

*Приложение

26. Микроклимат: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового излучения.

27. Качественная характеристика:

- постоянное или непостоянное воздействие;
- источники теплового излучения.

28. Качественная характеристика:

- соответствие санитарным нормам показателей микроклимата производственных помещений;
- перечень показателей, выходящих за пределы допустимых значений, их величины, продолжительность воздействия.

29. При выполнении работ на открытой территории приводятся сведения о наиболее вероятных, минимальных и максимальных значений среднемесячной температуры, относительной влажности воздуха, скорости ветра, интенсивности прямой солнечной радиации в данной местности для холодного (декабрь-февраль) и теплого (июнь - август) периода года.

30. Факторы трудового процесса.

а) Характеристика факторов организации рабочего места:

- рабочая поза (свободная вынуждения);
- время нахождения в вынужденной позе (в % от времени смены);
- наклоны корпуса (отсутствуют, вынужденные);
- углы наклона корпуса (градусы);
- количество наклонов (за операцию, за смену);

б) Характеристика факторов физической нагрузки:

- масса груза, перемещаемого вручную (кг.);
- откуда перемещается груз (с пола, с рабочей поверхности);
- расстояние подъема и перемещение груза (отдельно по каждому);
- частота подъема груза за операцию, за смену;
- сменный грузооборот (тонн);
- усилия, прикладываемые к основным органам управления (Н);

в) Характеристика факторов зрительного напряжения:

- работа с оптическими приборами или без них;
- наименьший объект различения, мм;
- контраст объекта различения;
- характеристика фона.

г) Характеристика режима труда и отдыха:

- сменность работы;
- длительность обеденного перерыва, мин.;
- наличие регламентированных перерывов, их длительность за смену.

[*приложение](#)

Приложение 16

к Порядок и периодичность проведения

обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров

ПЕРЕЧЕНЬ медицинских противопоказаний (в дополнение к общим медицинским противопоказаниям) для работников непосредственно связанных с обслуживанием населения

1. Заболевания и бактерионосительство:

- брюшного тифа, паратифов, сальмонеллеза, дизентерии;
- гистоплазмоза, энтеробиоза;
- сифилис в заражном периоде;
- лепра;
- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актинимикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
- гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;
- гнойничковые заболевания - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов.

2. ВИЧ/СПИД для медицинских работников хирургического профиля (хирурги, стоматологи, акушергинекологи и др.) специалисты службы переливания крови и других специалистов которых непосредственно связаны с кровью, специалисты инфекционных больниц и отделений которых имеется опасность обострения оппортунистических инфекций.

3. Парентеральные гепатиты ("В", "С") для медицинских работников хирургического профиля, специалистов службы переливания крови или другие специалисты непосредственно связанные с кровью.

4. Золотистый стафилококк для работников хирургического профиля, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также для работников занятым изготовлением и реализацией молочных и кондитерских пищевых продуктов.